

CHIPS info sessie - NL

Kwaliteitsindicatoren Infectiepreventie

12/03/2026



Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu



Praktische afspraken webinar

- **Programma**
 - 20 min – Presentatie over CHIPS
 - 20 min - Demo platform
 - 20 min – Q&A
- **Tijdens de presentaties**
 - Gelieve microfoon op mute te houden
 - Gebruik de chat zo weinig mogelijk
- **Vragen**
 - Vragen worden behandeld na beide presentaties
 - Gelieve de hand op te steken om een vraag te stellen
 - Gebruik de chat zo weinig mogelijk
- **Opname wordt beschikbaar gesteld**

CHIPS

*“Check
Hospital
Infection Prevention
Status”*



Doel webinar en agenda

Doel webinar

- Uitleg geven over CHIPS
- Toelichten hoe de tool werkt
- Verwachtingen voor IPC-teams verduidelijken
- Vragen beantwoorden

Presentatie webinar

- Inleiding en doel
- Validatie 2025
- Belangrijke principes
- Structuur CHIPS
- Scoring (groen/geel/oranje)
- Indicatoren
- Rapportage en validatie van de input data
- Nationale ondersteuning
- Timeline
- IPC platform

Inleiding en doel CHIPS

- = Een vernieuwde versie van de IPC-kwaliteitsindicatoren
- = Nationaal instrument voor monitoring van IPC in Belgische acute ziekenhuizen
- **Ontwikkeld door** Federaal Platform voor IPC – CHIPS Werkgroep; Sciensano IPC team; BAPCOC Support Team
- **Doel van CHIPS: IPC-programma's versterken**
 - Op ziekenhuisniveau:
 - Een pragmatisch overzicht geven van IPC-praktijken,
 - Interne reflectie en planning ondersteunen
 - Op nationaal niveau:
 - Een gestandaardiseerde monitoring van IPC mogelijk maken
 - Beleidsontwikkeling ondersteunen

→ Dubbele rol van CHIPS: monitoringsinstrument én instrument voor verbetering

Validatie CHIPS 2025

- 57 ziekenhuizen hebben deelgenomen
- We analyseerden:
 - Interviews
 - Thinking-aloud sessies
 - Open vragen uit de survey
 - Feedback via e-mail
 - IPCAF-scores
 - Interobserver reliability (overeenstemming tussen beoordelaars)
- Om na te gaan:
 - Validiteit
 - Betrouwbaarheid
 - Haalbaarheid

Resultaten van de validatie 2025

Betrouwbaarheid

- *Interobserver reliability van CHIPS was globaal matig*
- *Variatie tussen indicatoren en topics*
- *Minder overeenkomst bij training, monitoring, surveillance en prioritering*

Validiteit

- *Sterke en statistisch significante associatie tussen CHIPS en IPCAF-scores*
- *IPC-professionals beoordeelden CHIPS als nuttig voor reflectie en beleid*

Meerwaarde volgens IPC-teams

- *Helpt om het IPC-programma te structureren*
- *Ondersteunt ontwikkeling van beleid en actieplannen*
- *Faciliteert dialoog met management*

Uitdagingen

- *Tool is complex en relatief lang*
- *Interpretatie van sommige indicatoren moeilijk*
- *Niet alle IPC-activiteiten worden gedekt*
- *Moeilijk om alle topics groen te scoren binnen 3 jaar*

Peer-to-peer visits

- *Sterk gewaardeerd voor uitwisseling en leren tussen ziekenhuizen*

CHIPS Belangrijke principes

- IPC wordt gepositioneerd als een **verantwoordelijkheid van het hele ziekenhuis**, niet alleen van het IPC-team
- **Niet alle taken van het IPC team en comité** zijn er in verwerkt
- **Dynamisch instrument** dat in de tijd zal evolueren
- Stimuleert een verschuiving van een voornamelijk reactieve aanpak naar een gestructureerde **preventieve aanpak**
- Bevordert het actief **gebruik van surveillance- en monitoringsresultaten voor het plannen, implementeren en opvolgen van verbeteracties**: afgestemd op de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus
- Gebaseerd op een **multimodale strategie**: procedures, training, meten en terugkoppelen

Plan	Ziekenhuizen bepalen hun prioriteiten op basis van hun ziekenhuisbrede plannen en risicoanalyse, en stellen plannen op voor opleidingen, monitoring, surveillance en feedback, en andere verbeteracties.
Do	Ziekenhuizen implementeren concrete acties via een multimodale strategie , waaronder actuele procedures, opleiding en training, audits etc
Check	Resultaten van monitoring, surveillance en feedback worden geëvalueerd.
Act	Resultaten worden geïntegreerd in het verbeterplan of opgenomen in een risicoanalyse voor verdere opvolging.

CHIPS Belangrijke principes

- **Aanpasbaar aan de ziekenhuiscontext**
 - Ontworpen om af te stemmen op de lokale context
 - Houdt rekening met:
 - Lokale prioriteiten
 - Risicoprofielen
 - Maturiteit van het IPC-programma
- Gebaseerd op **eigen ziekenhuisplannen**
 - Evaluatie vertrekt vanuit bestaande eigen plannen, zoals:
 - Opleidingsplannen
 - Monitoringsplannen
 - Strategische plannen of actieplannen

Structuur CHIPS

35 indicatoren verdeeld over 10 IPC-topics
2–4 indicatoren per topic

Per topic wordt beoordeeld of

- ☐ Procedures geactualiseerd zijn
- ☐ Opleiding en training worden gegeven
- ☐ Monitoring en/of surveillance- en feedbackactiviteiten worden uitgevoerd

Doel: elk topic minstens één keer groen binnen een cyclus van 3 jaar

Topics	Indicators	Result		
Staffing & enabling environment	IPC staffing IPC referents Hospital staffing Single patient rooms			
Hand hygiene	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback			
Environmental & equipment cleaning	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback			
Transmission-based precautions and screening (MDR)O	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback			
Prevention CLABSI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback			
Prevention CAUTI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback			
Prevention nv-HAP	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback			
Prevention VAP	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback			
Prevention SSI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback			
Stakeholder involvement	Patient involvement Management involvement			

Scoring systeem

- Voor elke indicator wordt **één prestatieniveau gekozen**
- Alle criteria van een niveau moeten vervuld zijn om een hogere niveau te behalen
- **Drie niveaus**
 - Groen** – goede implementatie / bereikt
 - Geel** – gedeeltelijk bereikt / verbetering nodig
 - Oranje** – zwakke implementatie / belangrijke aandachtspunten
- CHIPS wordt beoordeeld **per ziekenhuis erkenningsnummer**, inclusief alle sites
- De indicator score is gebaseerd op de **site met de laagste score**
- **Score per topic**
 - Indicatoren worden gecombineerd tot één topicscore
 - Wanneer krijgt een **topic een groene score**?
 - Topics met 2 indicatoren: Beide indicatoren zijn groen
 - Topics met 3 indicatoren: Alle drie indicatoren zijn groen
 - Topics met 4 indicatoren: Procedures en training zijn groen én minstens één van monitoring of surveillance is groen

Personeelsbezetting & ondersteunende omgeving

Niveau	IPC staffing
Oranje	< 1 VTE IPC-personeel (IPC-verpleegkundige of IPC-arts) per 250 verantwoorde bedden
Geel	1 VTE IPC-personeel (IPC-verpleegkundige of IPC-arts) per 150 tot 250 verantwoorde bedden
Groen	> 1 VTE IPC-personeel (IPC-verpleegkundige of IPC-arts) per 150 verantwoorde bedden

Opmerking: Het groene niveau weerspiegelt personeelsbezetting die verder gaat dan de minimale vereisten in de Belgische wetgeving en erkent ziekenhuizen die hebben geïnvesteerd in het versterken van hun IPC-personeelscapaciteit.

Niveau	IPC referenten
Oranje	Geen actieve IPC-referenten
Geel	IPC-referenten aanwezig, maar niet in alle afdelingen
Groen	IPC-referenten aanwezig in alle afdelingen

Niveau	Ziekenhuis personeelsbezetting
Oranje	De V/P-ratio is vastgelegd en gebaseerd op historische normen. Zorgintensiteit wordt niet geëvalueerd en heeft geen invloed op personeelsbezetting.
Geel	De V/P-ratio wordt aangepast op basis van zorgintensiteit, maar: • zorgintensiteit wordt niet systematisch geëvalueerd, en/of • aanpassingen worden niet structureel toegepast.
Groen	De V/P-ratio wordt aangepast op basis van zorgintensiteit, en: • zorgintensiteit wordt systematisch geëvalueerd, en/of • aanpassingen worden structureel toegepast.

Indicator: beoordeelt in welke mate de verpleegkundige-patiëntratio wordt aangepast op basis van zorgintensiteit. In te vullen in overleg met het ziekenhuismanagement.

Opmerking: indicator is nog in ontwikkeling en kan worden aangepast op basis van informatie van ziekenhuizen over de meting van zorgintensiteit.

Niveau	Eenpersoonskamers
Oranje	% eenpersoonskamers t.o.v. het totaal aantal kamers $\leq$ 25%
Geel	% eenpersoonskamers t.o.v. het totaal aantal kamers tussen 25% en 60%
Groen	% eenpersoonskamers t.o.v. het totaal aantal kamers $\geq$ 60%

Acht IPC topics

- ☐ Handhygiëne
- ☐ Reiniging van omgeving & materiaal
- ☐ Transmissiegerichte voorzorgsmaatregelen en screeningpraktijken
- ☐ Preventie CLABSI, CAUTI, VAP, nv-HAP, SSI

Niveau	Procedures
Oranje	Geen procedure aanwezig, of een procedure is aanwezig maar in de afgelopen 5 jaar niet herzien of geactualiseerd.
Geel	Een geactualiseerde of herziene procedure (binnen de laatste 5 jaar) is aanwezig, maar niet toegankelijk voor de relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers voor implementatie.
Groen	Een geactualiseerde of herziene procedure (binnen de laatste 5 jaar) is aanwezig en toegankelijk voor de relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers voor implementatie.

Niveau	Training en opleiding
Oranje	Er is geen opleidingsplan voor “het topic” voor onboarding en continue opleiding (ook al worden er opleidingen gegeven).
Geel	Er is een opleidingsplan voor onboarding en continue opleiding rond “het topic”: • herzien of geactualiseerd in de laatste 5 jaar • met multimethod training (≥ 3 methoden) • met een gedefinieerde doelgroep (relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers) en onboarding-opleiding rond “het topic” wordt uitgevoerd volgens plan of continue opleiding rond “het topic” wordt uitgevoerd volgens plan..
Groen	Er is een opleidingsplan voor onboarding en continue opleiding rond “het topic”: • herzien of geactualiseerd in de laatste 5 jaar • met multimethod training (≥ 3 methoden) • met een gedefinieerde doelgroep (relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers) en onboarding-opleiding rond “het topic” wordt uitgevoerd volgens plan en continue opleiding rond “het topic” wordt uitgevoerd volgens plan..

Indicatoren IPC topics

- ☐ Handhygiëne
- ☐ Reiniging van omgeving & materiaal
- ☐ Transmissiegerichte voorzorgsmaatregelen en screeningpraktijken
- ☐ Preventie CLABSI, CAUTI, VAP, nv-HAP, SSI

Niveau	Monitoring en feedback
Oranje	Audits over de implementatie van maatregelen worden niet uitgevoerd, of feedback wordt niet gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers.
Geel	Audits over de implementatie van maatregelen worden uitgevoerd en feedback wordt gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers.
Groen	Audits over de implementatie van maatregelen worden uitgevoerd, feedback wordt gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers, en de resultaten worden geïntegreerd in een verbeterplan of gedocumenteerd in een risicoanalyse.

Opmerking:

Specificaties voor
Handhygiëne en omgevingsreiniging

Voor zorginfecties: ZORGBUNDLES ≠ checklists

Monitoring en feedback
OF
Surveillance en feedback

Niveau	Surveillance en feedback
Oranje	Surveillance wordt niet uitgevoerd, of feedback wordt niet gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers.
Geel	Surveillance wordt uitgevoerd en feedback wordt gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers.
Groen	Surveillance wordt uitgevoerd, feedback wordt gegeven aan alle relevante zorg- en ziekenhuismedewerkers, en de resultaten worden geïntegreerd in een verbeterplan of gedocumenteerd in een risicoanalyse.

Betrokkenheid van belanghebbenden

Niveau	Patiënten
Oranje	Er is geen betrokkenheid van patiënten bij IPC-activiteiten.
Geel	Er is een ziekenhuisbreed beleid om ervoor te zorgen dat patiënten worden geïnformeerd over infectierisico's en basismaatregelen voor IPC.
Groen	Er is een ziekenhuisbreed beleid om patiënten te informeren over infectierisico's en basismaatregelen voor IPC, en patiënten worden actief aangemoedigd om deel te nemen aan IPC tijdens hun zorg.

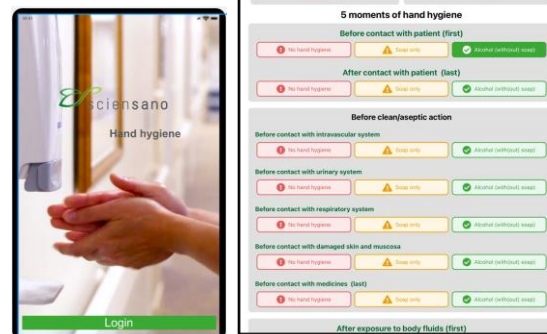
Niveau	Management
Oranje	Het ziekenhuismanagement (medische en verpleegkundige directie) neemt niet deel aan IPC-comités.
Geel	Het ziekenhuismanagement (medische en verpleegkundige directie) neemt deel aan minstens 4 IPC-comitévergaderingen per jaar.
Groen	Het ziekenhuismanagement (medische en verpleegkundige directie) neemt deel aan minstens 4 IPC-comitévergaderingen per jaar, en IPC is formeel verankerd in het ziekenhuisbrede strategisch/medisch plan, met duidelijke ondersteuning en verantwoordelijkheid van het management.

Rapportage en externe validatie zelf rapportage

- **2026** – Start van CHIPS rapportage alle ziekenhuizen - validatiejaar
 - Zelfrapportage door ziekenhuizen
 - Externe validatie van data in een random selectie van ziekenhuizen (Sciensano & BAPCOC Support Team)
 - Geaggregeerd rapport
 - Gegevens worden gedeeld met Bapcoc Support Team
- **Vanaf 2027** – Na volledige validatie
 - Externe validatie van data input blijft gebeuren in een random selectie van ziekenhuizen
 - Ziekenhuisresultaten worden publiek beschikbaar, met correcte contextualisering
 - Rapport met best practices, met voorbeelden van ziekenhuizen per topic

Nationale ondersteuning via NAP AMR 2026 - 2030

- **Algemene tools – door CHIPS Werkgroep**
 - Templates opleidingsplan, risico analyse, strategisch plan, ...
- **Toolbox online - door BAPCOC Support Team**
- **Richtlijnen – door HGR**
 - Omgevingsreiniging update HGR (voorzien 2027)
 - Nv-HAP (voorzien 2029)
- **Opleidingen – door BAPCOC Support Team**
 - Ontwikkeling van e-learningmodules en opleidingsmateriaal
- **Monitoring en feedback – door Sciensano met Federaal Platform**
 - Opstellen zorgbundels CLABSI, CAUTI, SSI, VAP, nv-HAP
 - Monitoring en feedback tool voor
 - Handhygiëne (2026)
 - Zorgbundels (2026)
 - Omgevingsreiniging (2027)
 - TBP



Topics	Indicators
Hand hygiene	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback
Environmental & equipment cleaning	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback
Transmission-based precautions and screening (MDR)O	Procedures Training and education Monitoring, audit and feedback
Prevention CLABSI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback
Prevention CAUTI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback
Prevention nv-HAP	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback
Prevention VAP	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback
Prevention SSI	Procedures Training and education Carebundle monitoring and feedback Surveillance and feedback

Binnen het AIM-project

- Peer-to-peer visits als element gekoppeld aan bijkomende financiering in het AIM project

Voor alle ziekenhuizen (los van AIM)

- Kwaliteitsindicatoren – CHIPS - blijft een wettelijke verplichting, ongeacht deelname aan AIM project
- Transparantie voor alle ziekenhuizen, ongeacht deelname aan AIM project

Timeline volgende stappen in 2026

Stap	Wie?	Beschrijving	timing
Interobserver betrouwbaarheid	Alle ziekenhuizen	Twee IPC-teamleden vullen de vragenlijst onafhankelijk en zonder overleg in via LimeSurvey. (20 ziekenhuizen hebben nog geen namen doorgegeven)	Link open: 13/03/2026 – 31/03/2026
Invullen CHIPS in IPC-platform	Alle ziekenhuizen	Het IPC-team vult de CHIPS-vragenlijst in consensus in via het IPC-platform.	01/04/2026 – 30/04/2026
Peer-to-peer bezoeken	Ziekenhuizen die deelnemen aan het AIM project	AIM-deelnemers bevestigen hun deelname. Vervolgens geven zij hun voorkeur voor ziekenhuizen die zij willen bezoeken. Op basis hiervan wordt een bezoeksplanning opgesteld.	Peer to peer bezoeken tussen 01/06/2026 – 30/09/2026
Externe validatie	Alle ziekenhuizen	Een random selectie van ziekenhuizen wordt bezocht om de ingevoerde data te valideren. Dit gebeurt los van de peer-to-peer bezoeken.	Timing volgt